CŒUR · VAISSEAUX · CV-01

# Coroscanner · CAD-RADS 2.0

**CAD-RADS 2.0 (SCCT/ACC/ACR/NASCI 2022)**
sténose, charge plaquaire, modificateurs

**Principe :** une catégorie par patient, fondée sur la **sténose la plus significative** (vaisseaux > 1,5 mm), complétée par la **charge plaquaire (P1–P4)** et des **modificateurs**. Format : **CAD-RADS [catégorie] / [modificateurs] / [P]**, ex. « CAD-RADS 3/HRP/P2 ».

## CATÉGORIES DE STÉNOSE · DOULEUR THORACIQUE STABLE

| CATÉGORIE | STÉNOSE MAXIMALE | INTERPRÉTATION | CONDUITE |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 %, ni plaque ni sténose | Absence de maladie coronaire | Pas d'autre exploration cardiaque |
| 1 | 1–24 %, ou plaque sans sténose (y compris remodelage positif) | Maladie minime non obstructive | Pas d'autre exploration ; prévention selon la charge plaquaire |
| 2 | 25–49 % | Maladie légère non obstructive | Pas d'autre exploration ; prévention |
| 3 | 50–69 % | Sténose modérée | Envisager une évaluation fonctionnelle : FFR-CT, perfusion CT, échographie de stress, scintigraphie, TEP, IRM, FFR invasive |
| 4A | 70–99 % sur 1 ou 2 vaisseaux | Sténose sévère | Coronarographie ou évaluation fonctionnelle ; coronarographie favorisée si > 90 %, HRP, ischémie ou symptômes persistants |
| 4B | **Tronc commun ≥ 50 %** ou atteinte **tritronculaire** ≥ 70 % | Sténose sévère | **Coronarographie recommandée** |
| 5 | 100 % (occlusion totale) | Occlusion totale ou subtotale | Coronarographie, évaluation fonctionnelle ou de viabilité |

Douleur thoracique aiguë : 0 SCA très improbable · 1 improbable · 2 peu probable · 3 possible · 4 probable · 5 très probable · N : SCA non exclu, autre exploration nécessaire. Intégrer troponine, ECG et HRP.

## CHARGE PLAQUAIRE

| CATÉGORIE | CHARGE | SCORE CALCIQUE (CAC) | SEGMENTS ATTEINTS (SIS) | ÉVALUATION VISUELLE |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Légère | 1–100 | ≤ 2 | 1–2 vaisseaux, peu de plaque |
| P2 | Modérée | 101–300 | 3–4 | 1–2 vaisseaux, plaque modérée ; ou 3 vaisseaux, peu de plaque |
| P3 | Sévère | 301–999 | 5–7 | 3 vaisseaux, plaque modérée ; ou 1 vaisseau, plaque importante |
| P4 | Étendue | > 1 000 | ≥ 8 | 2–3 vaisseaux, plaque importante |

En cas de discordance, privilégier le score calcique ou la quantification de la plaque totale ; retenir l'évaluation la plus sévère.

## MODIFICATEURS

### N · S · G · E

- **N** : examen non diagnostique (catégorie = sténose minimale certaine)
- **S** : stent
- **G** : pontage
- **E** : exception (anomalie de naissance, fistule, dissection, anévrisme…)

### HRP · plaque à haut risque

Au moins **2** des signes suivants :

- Plaque de **faible densité** (< 30 UH)
- **Remodelage positif** (≥ 10 % du diamètre de référence)
- **Calcifications ponctuées** (< 3 mm)
- **Signe de l'anneau** (« napkin-ring »)

### I · ischémie

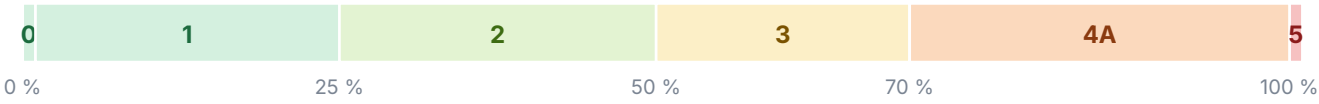
- **I+** : ischémie en FFR-CT ou perfusion CT
- **I−** : pas d'ischémie
- **I±** : limite
- À indiquer seulement si réalisé

# Coroscanner · CAD-RADS 2.0 (suite)



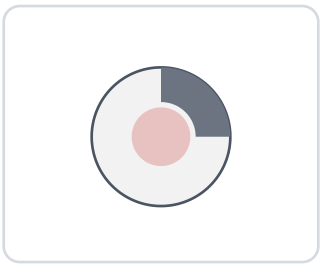
## ATLAS VISUEL

### Échelle de sténose et catégories

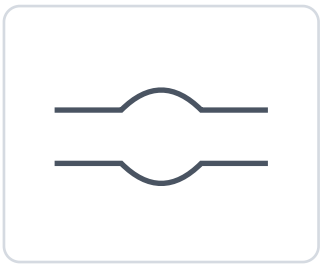



4B : tronc commun ≥ 50 % ou tritronculaire ≥ 70 % · 5 : occlusion totale

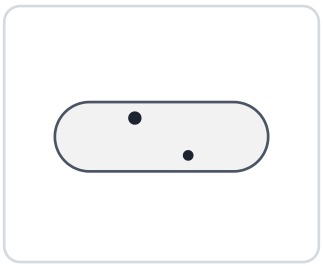
### Plaque à haut risque (modificateur HRP) : au moins 2 signes



**Faible densité**
< 30 UH



**Remodelage positif**
≥ 10 % du diamètre



**Calcifications ponctuées**
< 3 mm



**Signe de l'anneau**
napkin-ring

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**CAD-RADS**
Radiopaedia · catégories et modificateurs
radiopaedia.org/articles/coronary-artery-disease

**Plaque vulnérable**
Radiopaedia · signes de haut risque
radiopaedia.org/articles/vulnerable-plaque?lang=

**Signe de l'anneau (napkin-ring)**
Radiopaedia · définition
radiopaedia.org/articles/napkin-ring-sign-heart

**Remodelage positif et anneau (cas)**
Radiopaedia · coronaire droite
radiopaedia.org/cases/positive-remodeling-and-na

**CAC-DRS (score calcique)**
Radiopaedia · classes
radiopaedia.org/articles/coronary-artery-calcium

**Sources :** CAD-RADS 2.0 (JACC CV Imaging 2022) – www.jacc.org/doi/10.1016/j.jcmg.2022.07.002 · CAD-RADS 2.0 (Radiology: Cardiothoracic Imaging) – pubs.rsna.org/doi/10.1148/ryct.220183 · What is new in CAD-RADS 2.0 (HVT) – hvt-journal.com/articles/art351